

Historial Clinico - P002

Psiquiatria - Dra. Isabel Romero Castillo - Armilla (Granada)

1. Datos del paciente

ID Paciente	P002
NHC	NHC-2017-008765
Nombre completo	Antonio Herrera Lopez
Sexo	Hombre
Fecha nacimiento	15/12/1988
Edad	37 anos
DNI	24.567.891-G
Telefono	622 908 134
Municipio	Armilla (Granada)
Medico responsable	Dra. Isabel Romero Castillo
Especialidad	Psiquiatria

2. Antecedentes personales

- Esquizofrenia paranoide, episodios multiples, actualmente en remision parcial (diagnostico 2013, CIE-10: F20.0)
- Primer episodio psicotico a los 24 anos con hospitalizacion (2013)
- Segundo episodio psicotico en 2017 por abandono de medicacion
- Tercer episodio psicotico en 2022 tras consumo de cannabis
- Tabaquismo activo (20 cigarrillos/dia)
- Sindrome metabolico iatrogenico secundario a antipsicoticos
- Esteatosis hepatica no alcoholica
- No alergias medicamentosas conocidas

Antecedentes familiares: Padre: trastorno esquizoafectivo, diagnosticado a los 28 anos. Tio paterno: esquizofrenia, institucionalizado. Madre: trastorno depresivo recurrente. Hermano menor: sin patologia psiquiatrica conocida.

3. Historia clinica actual

Paciente de 37 anos con diagnostico de esquizofrenia paranoide desde 2013, en seguimiento ambulatorio. El primer episodio psicotico debuto con ideacion delirante de perjuicio (conviccion de que companeros de trabajo conspiraban para despedirle y de que su telefono estaba intervenido), alucinaciones auditivas en segunda persona de caracter despectivo y conducta suspicaz con aislamiento social progresivo, requiriendo ingreso involuntario durante 32 dias. Se inicio tratamiento con risperidona con respuesta parcial. El segundo episodio (2017) ocurrio tras abandono voluntario de medicacion durante 4 meses, con reactivacion de la tematica delirante persecutoria y anadiendo ideacion de referencia (creia que la television emitia mensajes dirigidos a el). Ingreso de 24 dias. Se roto a paliperidona palmitato mensual inyectable. El tercer episodio (2022) se desencadeno tras consumo continuado de cannabis durante 2 meses, presentando alucinaciones auditivas imperativas y heteroagresividad verbal hacia su madre, con ingreso de 18 dias. Desde entonces estable sin reingresos. Mantiene sintomas negativos residuales: aplanamiento afectivo, alogia moderada, abulia con dificultad para iniciar y mantener actividades y aislamiento social marcado. Vive con su madre de 68 anos que ejerce de cuidadora principal. Tiene prestacion por incapacidad permanente total. Acude a centro de rehabilitacion psicosocial (CRPS) 4 dias por semana. Lleva 3 anos sin consumir cannabis ni otros toxicos salvo tabaco. Niega ideacion autolitica. EEAG: 50.

4. Exploracion

Aspecto general	Consciente, orientado en las tres esferas. Higiene personal descuidada: pelo sin lavar, unas sin cortar. Vestimenta desalineada
Psicomotricidad	Sin agitacion ni inhibicion. Rigidez facial leve. Escasa gestualidad
Estado de animo	Eutimico. Afecto aplanado con minima modulacion emocional. No rie ni se emociona durante la entrevista
Pensamiento	Curso empobrecido con pobreza del contenido. Sin ideacion delirante activa. Sin fenomenos de insercion, robo o difusion del pensamiento
Sensopercepcion	Niega alucinaciones auditivas o visuales actuales. Refiere haber oido 'comentarios' hace 3 semanas, episodio aislado, autolimitado, sin repercusion conductual
Cognicion	Atencion sostenida disminuida. Funciones ejecutivas enlentecidas. Memoria de trabajo deficitaria. Dificultad en planificacion y secuenciacion
Conciencia de enfermedad	Parcial. Acepta el diagnostico y la medicacion pero minimiza la gravedad de los episodios previos y atribuye el tercero exclusivamente al cannabis
Peso / Talla / IMC	102 kg - 176 cm - 32,9 kg/m2
Tension arterial	142/90 mmHg
Frecuencia cardiaca	78 lpm, ritmica
Perimetro abdominal	112 cm

5. Tratamiento actual

Farmaco	Posologia
Paliperidona palmitato 150 mg	Inyeccion intramuscular mensual (ultima dosis: 08/04/2026)
Biperideno 2 mg	1 comp. en desayuno y cena (corrector extrapiramidal)
Metformina 850 mg	1 comp. con desayuno y cena (síndrome metabolico)
Atorvastatina 20 mg	1 comp. en cena
Omeprazol 20 mg	1 comp. en ayunas

6. Resultados de laboratorio

Parametro	Resultado	Ref.	Estado	Previo
Glucosa	122 mg/dL	70-110	Alto	116 mg/dL
HbA1c	6,3 %	< 5,7 %	Alto	6,0 %
Colesterol total	248 mg/dL	< 200	Alto	234 mg/dL
Trigliceridos	210 mg/dL	< 150	Alto	192 mg/dL
HDL	36 mg/dL	> 40	Bajo	38 mg/dL
LDL	168 mg/dL	< 130	Alto	155 mg/dL
Prolactina	48,6 ng/mL	4,0-15,0	Alto	45,2 ng/mL
GOT (AST)	42 U/L	< 40	Alto	38 U/L
GPT (ALT)	56 U/L	< 41	Alto	48 U/L
Hemograma	Normal	-	Normal	Normal

CPK	Normal	-	Normal	Normal
-----	--------	---	--------	--------

7. Plan de actuacion

1. Mantener paliperidona palmitato 150 mg/mes. No reducir dosis dado historial de 3 recaidas
2. Valorar rotacion a aripiprazol depot si prolactina sigue en ascenso (riesgo de ginecomastia y osteoporosis)
3. Derivacion a Endocrinologia para valoracion de prediabetes y sindrome metabolico
4. Programa de intervencion nutricional: dieta mediterranea hipocalorica supervisada por dietista del CRPS
5. Intensificar rehabilitacion psicosocial: anadir taller de autocuidado e higiene personal
6. Intervencion motivacional para cesacion tabaquica: valorar terapia sustitutiva con nicotina
7. Prevencion de recaidas: contrato terapeutico de abstencion de cannabis, refuerzo de consecuencias del consumo
8. Control analitico en 3 meses: glucosa, HbA1c, perfil lipidico, prolactina, hepatico
9. Revision psiquiatrica en 6 semanas

AVISO: Todos los datos de este documento son completamente ficticios. Generado para el TFG: Sistema RAG de apoyo en salud mental.